

BPSD 事件处理建议

生成时间：2026-05-18 16:03:01

《BPSD 事件处理建议》

长者姓名：陈萍忠

事件日期：返院第3天上午10:00

报告生成时间：当前

一、处置等级

轻度（Level 1）

本次事件为轻度BPSD相关行为波动，表现为拒绝配合康复训练，无言语或肢体过激行为，情绪可安抚，生命体征平稳，BPSD症状整体呈改善趋势（NPI评分16分），不符合中重度行为紊乱标准。

二、继续观察条件

满足继续观察条件，具体包括：

- 老人情绪已平稳，无持续烦躁、激越或攻击倾向；
- 生命体征正常（心率60次/分，血压血脂控制良好）；
- 无新发躯体不适（如头晕、胸闷、腹痛、发热等）；
- BPSD症状未出现复发或加重迹象；
- 日常生活能力维持稳定，仅洗澡需协助；
- 照护团队已实施有效安抚措施，家属虽焦虑但可沟通。

三、护士介入条件

暂不满足护士介入条件。

当前无以下情形：

- 生命体征异常或不稳定；
- 自伤、伤人、走失等安全风险；
- 急性药物不良反应；
- 需专业护理评估的躯体症状（如疼痛、出血、感染征象）。

建议由一线照护员按现有方案持续观察。

四、GP介入条件

****暂不满足GP介入条件**。**

当前无以下指征：

- BPSD症状显著恶化（如NPI评分上升、出现幻觉/妄想/攻击）；
- 新发或加重的躯体疾病；
- 需调整精神类药物（如奥氮平、劳拉西泮）剂量；
- 实验室检查异常（如电解质紊乱、感染指标升高）。

若后续出现上述情况，应立即启动GP会诊。

五、后续观察重点

1. ****BPSD行为演变****：密切监测是否出现言语攻击、肢体抗拒、游走、昼夜颠倒等升级行为。
2. ****康复依从性****：记录每日对认知/运动干预的配合程度，识别拒绝诱因（如疲劳、环境刺激、躯体不适）。
3. ****家属情绪支持****：主动沟通老人病情进展，提供BPSD应对指导，缓解其焦虑，避免家属过度干预影响照护一致性。
4. ****基础健康风险****：
 - 心率及循环状态（尤其日间活动时）；
 - 皮肤完整性（预防擦伤/淤青）；
 - 胃肠道功能（警惕呕吐、腹泻复发）。
5. ****非药物干预优化****：结合老人喜好（如跳舞），设计更柔性、短时、高愉悦感的活动，提升参与意愿。

六、升级流程是否触发

****否**。**

本次事件属预期范围内的轻度行为波动，未触及护士或GP介入阈值，****无需启动风险升级流程****。维持当前照护计划，加强观察与记录即可。

****备注****：本建议基于最新事件报告生成，历史风险（如皮肤损伤、心动过缓）已纳入长期照护目标，但不影响本次事件的低风险判定。